

·用药百问百答·

糖尿病患者选择降压药物的顺序及为何要首选普利类降压药

杨玺

017000 内蒙古鄂尔多斯市中心医院心血管内科

糖尿病患者选择降压药物的顺序

糖尿病高血压患者该如何选择降压药,既能积极控制血压,又不会引起血糖的增加呢?几类常用的降压药对血糖的影响差别较大,伴有糖尿病的患者要审慎选择。

血管紧张素转换酶抑制剂(普利类)和血管紧张素Ⅱ受体拮抗剂(沙坦类)是高血压合并糖尿病的安全有效的首选药物。普利类一方面可以扩张肾小动脉,降低肾小球压力,减少尿中的蛋白;一方面又能提高胰岛素的敏感性,有利于控制血糖。大量研究证明,普利类对控制新发糖尿病有较好的作用。普利类药物主要有卡托普利(开博通)、依那普利(依苏)等。沙坦类可增强胰岛素对葡萄糖的反应,同时保护肾脏,还能预防糖尿病和心脑血管

血管疾病,主要有缬沙坦(代文)和氯沙坦(科素亚)等。

钙拮抗剂(地平类)有良好的降压作用,对糖代谢并无影响,广泛应用于高血压、冠心病、脑血管病的治疗。此类药物也可作为糖尿病合并高血压病患者进行降压治疗的首选药物,对人体内的糖代谢无不良影响。常用的药物有硝苯地平、尼卡地平、尼群地平、氨氯地平(络活喜)、非洛地平(波依定)、维拉帕米缓释片(缓释异博定)等。不过临床发现,使用硝苯地平控释片(拜心同)对血糖有一定的影响。

此外,糖尿病合并高血压病的患者还应定期进行血糖监测,力争把血糖控制在理想水平。这样更有利于糖尿病合并高血压病患者的降压治疗。

糖尿病患者为何要首选普利类降压药

在2型糖尿病患者中,约有一半人患有高血压,两病并存时,常可加速血管和微血管病变的发生和发展。患了糖尿病又合并高血压,患者需要

终生控制血糖和血压。由于不少抗高血压药物对降糖治疗有一定的影响,所以患者要慎重选择降压药物。糖尿病患者为何要首选普利类降压药呢?这是因为血管紧张素转换酶抑制剂(普利类降压药)对糖尿病患者具有以下作用:①在发挥降压作用的同时,还可提高肌肉和脂肪对胰岛素的敏感性,这一点对使用胰岛素控制血糖的病人尤为重要。②对血糖、血脂可抑制动脉平滑肌细胞增殖,防止动脉粥样硬化形成,减轻或逆转左心室肥厚,改善心肌功能。④对早期糖尿病合并肾病的病人可明显降低微量蛋白尿,具有保肾功能。血管紧张素转换酶抑制剂品种较多,包括卡托普利(开博通)、苯那普利(洛汀新)、赖诺普利、培哚普利、福辛普利(蒙诺)等。需要指出的是,这些药物有极少数病人服后可能出现干咳等不良反应,停药后干咳症状随即消失。

如果单用血管紧张素转换酶抑制剂,血压控制未能达标时,就应考虑联合用药了。

药物相互作用速查

甘草

泼尼松 甘草有类皮质激素的药理作用,与皮质激素类联用可使药效增强。甘草酸的这一性质认为是由于它可以抑制11-β-羟甾脱氢酶,使内源或外源性皮质激素的氧化受阻,结果加强了药效。

口服避孕药 两药联用可致排钾增多,加重高血压和导致水肿。

丹参

华法林 体外丹参有抑制血小板聚集作用,体内可加强华法林作用,使机体处于低凝血酶原状态,加强出血倾向。丹参对其他抗凝血药也有类似作用。

银杏(叶)

华法林 对华法林稳态治疗者,加用本品可引起出血时间延长,乃至引发出血,应密切观察,根据需要调整药物剂量。

曲唑酮 银杏与曲唑酮合用造成1例阿尔茨海默病患者昏迷,经注射氟马西尼,病人立即苏醒,因此两药联用应谨慎。虽系个别病例,但应对曲唑酮的不良反应进行监控,降低剂量或停用银杏。

阿司匹林 银杏内酯有抑制血小板活性作用,同时服用两药可能使出血时间延长和发生出血意外。应加强出血检验和体征监测。

当归

华法林 当归可加强华法林作用,增加出血危险,小心监测血凝状态。

对其他口服抗凝药也有类似作用。

大蒜

华法林 大蒜诱导细胞色素P450 3A4同工酶,加速华法林代谢,可使国际标准化比值升高而引起出血。

沙奎那韦 大蒜可诱导细胞色素P450 3A4同工酶,可使沙奎那韦的平均谷值、AUC、C_{max}降低。

槟榔

苯海索 槟榔碱具有拟胆碱作用,苯海索的作用受槟榔碱拮抗而降效。

沙丁胺醇 沙丁胺醇的支气管舒张作用被槟榔碱拟胆碱作用所拮抗而降效。其他β₂激动药与槟榔碱之间也有类似作用。